EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 68985
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-11 10:13:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ALEXANDER SALVADOR ARIAS MARTINEZ			**RUN**	: 17.976.025-8
F.Nac	: 26-12-1991	**Edad**	: 31 AÑOS, 7 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: AGUA BUENA			**Comuna**	: CHILLAN
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 10-08-2023	**Fecha Egreso**	: 2023-08-11 10:13:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. L03.1-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIENBROS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Celulitis muñeca izquierda en resolucion
Artritis reactiva???

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. L03-CELULITIS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de miocarditis viral en mayo 2023, consulta el 09/08 por cuadro de sensacion febri, algia y eritema en ESI, cuenta con consulta precia en extrasistema el 07/08, donde se diagnostica celulitis y se inicia terapia ATB con cefadroxilo, con respuesta torpida.
En consulta en SU del 09/08 se agrega AVO en codo derecho.
Rx de muñeca y codo no se evidencian lesiones liticas oseas
Al examen fisico vigil, OTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades se aprecia edema y eritema en muleca izquierda, sumado a edema y eritema en codo derecho.
Se decide hospitalizar para tratamiento ATB
Paciente evoluciona de forma favorable, con disminucion de eritema y edema

Paciente actualmente cursando su dia N° 2 hospitalizado, HDN estable, afebril, sin dolor, sin episodios de nauseas y/o vomitos, sin peak febril, con buena tolerancia a alimentacion VO, diuresis y deposiciones (+)
Examenes de lab control -> lactato 1,3; PCR 45,7; Na/K/Cl 142/4/107 Gb 8,6
Titulo ASO (-), FR < 8,6; C3 153; C4 18,7; RPR no reactivo
Ex fisico -> Vigil, OTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades sin edema, sin signos de TVP, en region de nuñeca izquierda sin eritema ni AVO, sin induracion
Paciente actualmente en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso/cutaneo: Con parametros inflamatorios en disminucion, se continuara con terapia ATB via HODOm, sumado a control de parametros inflamatoios dentro de 3 dias

4) inmunlogico: Se complementara estudio con ANA, ENA y serologia VIH, control poli medicina interna dentro de 15 dias

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen liviano a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 5 dias
4. Paracetamol 500 mg; 2 comp c/8 hrs VO SOS por 5 dias
5. Metamizol 300 mg c/8hrs VO por 5 dias
6. Omeprazol 20 mg al dia VO por 5 dias
7. Pendiente resultado de VIH
8. Pendiente rescate de cultivos
9. Control poli medicina interna dentro de 15 dias
10. Examenes de control dentro de 3 dias

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO